IMSS

Dirección de Prestaciones Médicas

Coordinación de Proyectos Especiales en salud

Guía para la elaboración del Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres

Índice

Índice 1
Directorio 2
1. Objetivo, alcance y definiciones 4
2. Principios generales de actuación 5
3. Procedimiento operativo para elaborar y/o actualizar el PH-RED 6
3.1 Fase 0. Preparación 7
3.1.1. Conformar el equipo de trabajo del PH-RED 7
3.1.2. Definir funciones y responsabilidades del equipo que elabora o actualiza el plan. 7
3.1.3. Elaborar el plan de trabajo para la elaboración o actualización 7
3.1.4. Recopilar información y documentos existentes 7
3.2 Fase 1. Elaboración del Plan Hospitalario 8
3.2.1. Contexto. Registro de la información general del establecimiento de salud. 8
3.2.2. Marco normativo y objetivos 8
3.2.3. Evaluación de riesgos 8
3.2.4. Análisis del impacto y continuidad operativa 9
3.2.6. Planeación de actividades a partir del alertamiento u ocurrencia de un evento. 10
3.2.7. Elaborar los documentos específicos de planificación para la respuesta 11
3.3 Fase 2. Puesta prueba del plan 12
3.3.1. Paso 1. Definir qué se quiere probar 12
Paso 2. Planificar el ejercicio 12
Paso 3. Comunicar y preparar 12
Paso 4. Ejecutar el ejercicio 13
Paso 5. Evaluar resultados 13
Paso 6. Actualizar el PH-RED y la herramienta 13
4. Anexos 14
Anexo 1. Diagrama de flujo para la elaboración del plan hospitalario de respuesta a emergencias y desastres (PH-RED) 14
Referencias 16
Recursos 17
Contacto 18

Directorio

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Dirección General

Dr. Jorge Gaviño Ambriz
Secretaría General

Dra. Alva Alejandra Santos Carrillo
Dirección de Prestaciones Médicas

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Mtro. Borsalino González Andrade
Dirección de Administración

Lic. Luisa Obrador Garrido Cuesta
Dirección de Incorporación y Recaudación

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Dirección Jurídica

Mtra. Claudia Laura Vázquez Espinoza
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo
Dirección de Finanzas

Lic. Javier Guerrero García
Dirección de Operación y Evaluación

Mtro. Arturo De Lucio Ortega
Dirección de Planeación para la Transformación Institucional

Dra. Janett Alvarado González
Coordinación de Proyectos Especiales en Salud

Este documento fue elaborado por la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS. Su contenido se fundamenta en la Ley General de Protección Civil, en particular en el artículo 2, relativo al Programa Hospital Seguro, y en los artículos 39 y 40, referentes al Programa Interno de Protección Civil en hospitales; así como en la NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

Además, incorpora recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y evidencia de mejores prácticas para la elaboración de programas de preparación, orientados a fortalecer la respuesta a emergencias y desastres y los procesos de recuperación, en concordancia con los ítems 115, 117, 118 y 119 del ISH. De igual forma, se alinea con la evidencia disponible sobre gestión de emergencias en salud y sobre la elaboración del Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres y sus planes de contingencia (ítems 120 y 121 del ISH), así como con los procedimientos operativos relacionados (ítems 122, 123 y 124 del ISH).

Es responsabilidad de cada establecimiento de salud adaptar las recomendaciones aquí vertidas, considerando sus capacidades, recursos, nivel de atención, análisis de riesgos y condiciones particulares, bajo el criterio técnico y profesional del personal responsable, priorizando la seguridad de pacientes, personal y la continuidad de los servicios.

Derechos reservados © 2026
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos patrimoniales.

1. Objetivo, alcance y definiciones

Objetivo general

Estandarizar el procedimiento operativo para que los establecimientos de salud del IMSS elaboren, actualicen e implementen su Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres (PH-RED), a fin de garantizar una respuesta organizada, segura y oportuna ante emergencias y desastres, protegiendo la vida de pacientes, personal y visitantes y asegurando la continuidad de los servicios críticos.

Objetivos específicos

- Organizar el mando y coordinación al interior del establecimiento de salud
- Ordenar los flujos de pacientes y recursos en situaciones de alta demanda
- Articular al establecimiento de salud dentro de una red integrada de servicios de salud y otros actores
- Estandarizar procedimientos para distintos tipos de amenaza (enfoque multiamenaza)
- Definir cómo se escalan y desescalan las acciones durante una emergencia
- Integrar a personas en situación de vulnerabilidad en la respuesta
- Facilitar la capacitación, realización de simulacros y mejora continua
- Dar cumplimiento a la normativa institucional y al marco legal nacional/internacional
- Incorporar medidas para ciber amenazas que puedan interrumpir sistemas críticos, asegurando la continuidad digital.

Ámbito de aplicación. Aplica a todos los establecimientos de salud de primero, segundo y tercer nivel, unidades complementarias y sus servicios críticos (urgencias, hospitalización, terapia intensiva, tococirugía, quirófanos, laboratorio, entre otros).
Se articula con el Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres, el Programa Interno de Protección Civil y los Planes específicos o de contingencia.

Definiciones clave:

- **Amenaza:** Fenómeno de origen natural, tecnológico, sanitario o antrópico que puede causar daño al hospital, a su personal, pacientes y entorno.
- **CVOED:** Es el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres, administrado por la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS.
- **Desastre:** Situación en la que la demanda excede la capacidad de respuesta normal del establecimiento, requiere medidas extraordinarias (expansión, reconversión, apoyo externo) y genera alteraciones graves en la prestación de servicios.

- **Emergencia:** Situación que requiere respuesta inmediata, pero que puede ser atendida con los recursos disponibles, sin alterar de forma sustantiva la estructura y funciones de la unidad.
- **Evaluación estratégica del riesgo para establecimientos de salud.** Proceso sistemático y continuo para evaluar los riesgos más importantes que enfrenta un establecimiento de salud y su organización, a fin de priorizarlos y gestionarlos.
- **PH-RED:** Documento normativo y operativo que define cómo el establecimiento se organiza, se coordina y actúa antes, durante y después de una emergencia o desastre, para proteger vidas, mantener la continuidad de servicios críticos y recuperar la operación.
- **Riesgo:** Probabilidad de que la interacción entre una amenaza y las vulnerabilidades genere impactos adversos sobre la salud y la operación del establecimiento.
- **Servicios críticos:** Servicios esenciales para la seguridad de los pacientes y la continuidad operativa (urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), quirófanos, banco de sangre, laboratorio clave, imagenología, sistemas de información, energía, gases medicinales y agua).
- **Sistema de Comando de Incidentes (SCI).** Modelo de gestión estandarizado y flexible utilizado para coordinar la respuesta a emergencias o desastres.
- **Sistema de Comando de Incidentes para Establecimientos de Salud (SCI-H)** es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento o incidente.
- **Vulnerabilidad:** Condiciones internas que aumentan la posibilidad de daño (deficiencias en estructura, organización, procesos, recursos, capacitación, etc.).
- **Ciber amenaza:** Ataque intencional o accidental a sistemas informáticos, como ransomware, que compromete la confidencialidad, integridad o disponibilidad de datos y operaciones hospitalarias.

2. Principios generales de actuación

1. **Enfoque multiamenaza y ciclo de gestión del riesgo.** El PH-RED debe considerar todas las amenazas relevantes para el hospital (sismos, saldo masivo de víctimas (SMV), incendios, inundaciones, fallas de servicios críticos, brotes epidémicos, amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas (QBRNE), violencia armada, etc.), articulado con el ciclo de la gestión del riesgo: prevención - preparación - respuesta - recuperación.
2. **Cumplimiento del marco legal.** El plan debe cumplir con:
    - Normatividad Institucional.
    - Marco legal de Salud y Protección Civil.

- Alineado a las recomendaciones internacionales.

3. **Enfoque de continuidad operativa y seguridad del paciente.** El PH-RED no sólo busca salvar vidas durante la emergencia, sino mantener o restablecer la operación de los servicios críticos en el menor tiempo posible, minimizando eventos adversos y daños asociados a fallas en la atención.
4. **Participación multidisciplinaria e interinstitucional.** En la formulación del plan deben participar la dirección, mandos intermedios como jefes de servicio y/o coordinadores, personal operativo, así como enlaces con otras unidades de la red y autoridades externas locales (Centros reguladores de urgencias, Protección Civil, seguridad, Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), etc.).
5. **Enfoque en grupos en situación de vulnerabilidad.** El diseño de flujos, áreas de expansión y procedimientos debe considerar explícitamente a niñas y niños, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad barreras de comunicación o movilidad.
6. **Mejora continua y enfoque no punitivo.** El PH-RED es un documento cambiante, que se ajusta con base en lecciones aprendidas de eventos reales y simulacros. Las brechas identificadas deben orientar la mejora de sistemas, no la sanción individual.
7. **Estandarización del proceso.** La herramienta PH-RED_VF https://1drv.ms/f/c/3857830a47a17b3d/IgB2shwsc_cRS5BZVIjn7FStARVG0XqW1M10RCUPfdIXTzM?e=zWmZnc es un instrumento estandarizado de apoyo para capturar, ordenar y actualizar el contenido del plan; esta guía esta armonizada para llenarla de manera lógica y coherente.
8. **Aprendizaje y mejora continua.** Implica capacitar y realizar entrenamientos periódicos, llevar a cabo simulacros (incluidos ejercicios de escritorio, funcionales y de despliegue) y actualizar los procedimientos después de cada evento real o práctica, con el fin de fortalecer de manera continua la capacidad de respuesta.
9. Integración tecnológica y ciberseguridad. Incorporar herramientas digitales seguras y protocolos contra ciberataques para mantener la operatividad de sistemas críticos durante emergencias.

3. Procedimiento operativo para elaborar y/o actualizar el PH-RED

El proceso **para elaborar el plan** se organiza en fases,

Fase 0. Preparación

Fase 1. Elaboración del plan

1.1 Análisis del riesgo

1.2 Análisis del impacto y continuidad

1.3 Fase de alerta

1.4 Fase de respuesta

1.5 Fase de recuperación

Fase 2. Puesta a prueba del plan

A continuación, se describe como desarrollar cada fase y como se vincula con la herramienta PH-RED_VF para facilitar o guiar el proceso, incorporando acciones de salud mental en todas las fases para mitigar impactos en el personal y pacientes.

3.1 Fase 0. Preparación

Objetivo: Organizar el proceso de trabajo para formular o actualizar el PH-RED.
Pasos operativos:

3.1.1. Conformar el equipo de trabajo del PH-RED

- Integrantes: miembros del Comité de Emergencias del Hospital, dirección del hospital, responsables de urgencias, UCI, quirófanos, enfermería, conservación, informática, seguridad, trabajo social, administración, representante de las personas con discapacidad, incluir un experto en ciberseguridad para abordar riesgos digitales
- Registrar esta conformación en el plan de trabajo (puede apoyarse de la herramienta Excel en la sección “PREPARACIÓN”).

3.1.2. Definir funciones y responsabilidades del equipo que elabora o actualiza el plan.

- Establecer quién coordina el proceso, quién consolida la información y quién captura en el documento preliminar. Puede utilizar la herramienta en Excel PH-RED_VF para apoyarse.
- Asegurar que al menos una persona tenga dominio del documento y herramientas.
- Asignar responsabilidad específica para evaluar vulnerabilidades cibernéticas.

3.1.3. Elaborar el plan de trabajo para la elaboración o actualización

- El coordinador designado por la dirección deberá presentar un plan con actividades definidas, fechas (cronograma), productos entregables y asignación de tareas.
- Fechas de inicio y término por actividad.
- Responsable de cada actividad.
- Encargado de capturar la información (actividad, responsable, fecha límite, estatus), sea utilizando la herramienta anexa o en otro documento.
- Incluir revisiones periódicas para amenazas emergentes como cibernéticas

3.1.4. Recopilar información y documentos existentes

- Identificar las fuentes u origen de la información, documentos, sistemas, usuarios, etc.
- Planes previos de emergencias o desastres.

- Programa Interno de Protección Civil, y su Plan de continuidad de Operaciones así como sus procesos críticos
- Manuales y procedimientos clínicos y administrativos.
-
- Lecciones aprendidas de eventos reales o simulacros previos.

3.2 Fase 1. Elaboración del Plan Hospitalario

3.2.1. Contexto. Registro de la información general del establecimiento de salud.

i. Datos de identificación de la unidad, tipología y fechas de construcción, datos sobre vulnerabilidades climáticas locales, entre otros.
ii. Información de la ubicación incluyendo dirección y datos de geolocalización.
iii. Facilidades para la comunicación y transporte.
iv. Información base sobre su capacidad instalada, así como los servicios críticos.
v. Especialidades disponibles dentro de una red integrada de servicios.
vi. Integrar escenarios de cambio climático y ciberataques.

3.2.2. Marco normativo y objetivos

vii. Describir cual es el marco normativo vigente que apoye la elaboración e implementación del plan; principales leyes, normas nacionales o locales, así como lineamientos institucionales y externos aplicables.
viii. Documentar la relevancia del PH-RED para la seguridad de los ocupantes de la instalación (pacientes, personal y visitantes), para la continuidad operativa y el cumplimiento normativo, describiendo los objetivos para los que está diseñado.
ix. El documento debe mencionar nombre y cargos de quienes lo elaboran y aprueban, así como las fechas de creación y de última actualización.
x. Alinear con ISO 22301 para gestión de continuidad.

3.2.3. Evaluación de riesgos

xi. **Eventos previos.** Registrar los eventos históricos que han afectado al hospital (sismos, inundaciones, incendios, fallas de energía, SMV, brotes, etc.), con fecha, tipo de daño y consecuencias en la operación.
xii. **Identificación de amenazas.** Identificar y registrar todas las amenazas relevantes para el establecimiento de salud, clasificándolas por tipo: Geológicas (sismo, deslizamientos, volcán, etc.), Hidrometeorológicas (inundación, lluvias intensas, huracanes, ondas de calor, etc.), Sanitarias (epidemias, brotes nosocomiales, pandemias), Tecnológicas (incendios, explosiones, sustancias peligrosas, fallas de

energía, fallas de gases medicinales) y Antrópicas (violencia armada, SMV, terrorismo, bloqueo de accesos, etc.), ciberataques (ransomware, DDoS).

xiii. Registrar, para cada una de ellas, los periodos del año con mayor probabilidad de ocurrencia, así como sus características y efectos potenciales sobre la unidad.

xiv. **Análisis de vulnerabilidades.** Registrar todas aquellas relacionadas con Infraestructura física (edificación, accesos, sistemas críticos), con la organización y procesos (existencia de planes, brigadas, entrenamiento) y con los recursos (personal crítico, insumos, equipos, comunicaciones). Puede incorporar estos elementos en una matriz de valoración cualitativa o semicuantitativa de riesgo (contemple utilizar la matriz de riesgos sugerida en la herramienta PH-RED_VF).

xv. **Estimación del riesgo.** Para cada amenaza relevante, estimar el nivel de riesgo (por ejemplo, bajo/medio/alto) en función de la probabilidad y el impacto potencial sobre el hospital. Este resultado debe orientar las prioridades del PH-RED y de los planes de contingencia con los que debe contar el establecimiento de salud.

3.2.4. Análisis del impacto y continuidad operativa

xvi. **Identificar los servicios críticos del establecimiento de salud.** Urgencias, UCI adultos/pediátrica, quirófanos, tococirugía, hemodiálisis, hospitalización crítica, banco de sangre, laboratorio de urgencias, imagenología de urgencias, sistemas informáticos, comunicación interna, energía, agua, gases medicinales, impacto en sistemas digitales y datos de pacientes, entre otros.

xvii. **Evaluar el impacto de su interrupción.** ¿Qué ocurre si el servicio se detiene 1 hora, un turno, 24 horas, 72 horas?, ¿Qué riesgos para la vida de los pacientes se generan? Registrar este análisis en el documento (impacto cualitativo y/o tiempos máximos tolerables) de modo que pueda ser comparativo en una actualización posterior.

xviii. **Determinar la cantidad de personal esencial y recursos críticos.** Por cada servicio crítico, definir: número y perfil de personal esencial para mantener operación mínima, equipos fundamentales (ventiladores, monitores, bombas de infusión, etc.), insumos fundamentales (medicamentos, hemocomponentes, material de curación, combustible, etc.).

xix. **Definir alcances y premisas del plan.** Determinar hasta dónde puede llegar el hospital con recursos propios (autonomía mínima en días). Establecer qué apoyos externos son previsibles y en cuánto tiempo podrían llegar.

xx. **Seleccionar estrategias para la continuidad de los servicios.** Reducción temporal de cartera de servicios. Reubicación de servicios críticos dentro del establecimiento de salud. Uso de acuerdos con otros establecimientos para referencia y contrarreferencia.

3.2.5. Organización para la respuesta

xxi. **Instalación o ratificación del Comité Hospitalario.** Documentar el Comité Hospitalario para Emergencias y Desastres (CHED) mediante acta constitutiva. El registro debe contener los nombres de los integrantes, sus cargos, funciones generales, la fecha de instalación y la composición sean titular o suplente, sin omitir la representación de las personas con discapacidad.

xxii. **Determinar la ubicación del COE principal y el COE alterno.** El espacio físico debe estar habilitado con teléfonos, extensiones, red inalámbrica (wifi), ser accesible y estar en un lugar seguro.

xxiii. **Definir y documentar la estructura organizativa para la respuesta.** Utilizar el esquema de Sistema de Comando de Incidentes para Hospitales (SCI-H). Los cargos y funciones deben quedar registrados y validados, ej.: Comandante del incidente (Director del hospital o quien se designe). Secciones y responsables de Operaciones, Logística, Planeación, Información, Administración, Finanzas, Seguridad, Comunicación y gestión de ciber incidentes. Para cada cargo clave, completar la tarjeta de acción correspondiente (qué hace antes, durante y después de la emergencia).

xxiv. **Organizar y registrar las brigadas.** El registro de quienes han sido asignados en cada turno a las brigadas de Prevención y combate de incendios, evacuación y repliegue, primeros auxilios, fluidos y energéticos, comunicación, búsqueda y rescate, brigada(s) especial(es), además de las que considere necesarias. Considere un perfil mínimo de integrantes, entrenamiento requerido, así como turnos de relevos.

3.2.6. Planeación de actividades a partir del alertamiento u ocurrencia de un evento.

xxv. **Definir el procedimiento de activación y niveles de alerta.** Adoptar un esquema tipo semáforo (Verde–Amarillo–Rojo) o por nivel en función del riesgo determinado para el establecimiento (grado I, Grado II, Grado II), asociado al grado de impacto previsto para la unidad y la necesidad de apoyo externo. Establecer los criterios operacionales para pasar de un nivel de alerta a otro (número de víctimas, tipo de evento, daños a infraestructura, número de servicios comprometidos, etc.).

xxvi. **Establecer la cadena de llamadas.** Especificar quién activa la cadena (máxima autoridad del hospital o responsable en el momento), dejando claro el orden en que serán notificados los funcionarios, Director, Subdirectores, Jefes de Servicio, personal clave, enlaces con OOAD o UMAEs y CVOED.

xxvii. **Definir los mensajes estandarizados de alerta.** Establecer el contenido del mensaje que debe transmitirse: tipo de evento, lugar, hora, demanda estimada,

instrucciones específicas. Si son necesarios mensajes internos, así como los medios por los cuales se difundirán (altavoz, radios, mensajería electrónica y los códigos); los mensajes externos a CRUM, CVOED, Protección Civil y otras instancias.

3.2.7. Elaborar los documentos específicos de planificación para la respuesta

xxviii. **Desarrollo de planes de contingencia.** Con base en las amenazas identificadas que representan un riesgo alto para el establecimiento de salud, construir un plan de contingencia para cada amenaza (ej.: sismo, inundación, incendio, etc.). Cada plan debe especificar brevemente el contexto o escenario de referencia, los objetivos específicos alcanzables por periodos de tiempo, la secuencia de acciones antes, durante y después de que la amenaza se manifieste, los roles y responsabilidades (vinculados a tarjetas de acción) y claramente las necesidades críticas de recursos.

xxix. **Alinear los procedimientos operativos.** Para la ejecución del PH-RED y sus planes de contingencia, se requieren de procedimientos homologados con los que se operativiza la respuesta. Estas acciones deben responder a las necesidades específicas de cada escenario. Por ejemplo, si es necesario evacuar la instalación o expandir la capacidad instalada, independientemente de la causa, se deben desarrollar una secuencia de acciones operativas; algunas recomendaciones a considerar son:

- **Procedimiento para la expansión y reconversión.** Identificar áreas que se pueden habilitar temporalmente para: triage, choque/trauma, observación, observación intermedia, cirugía, hospitalización masiva, depósito temporal de cadáveres, etc. Registrar para cada área: capacidad máxima (número de camas o pacientes), requerimientos de recurso humano con roles y responsabilidades, requerimientos logísticos (oxígeno, energía, agua, iluminación, sanitarios, accesibilidad).
- **Procedimiento de evacuación del establecimiento, incluyendo sus áreas críticas.** Señalizar y habilitar rutas de evacuación, áreas de menor riesgo, algoritmo para la toma de decisiones, responsables de activar la decisión, funciones del personal operativo, etc.
- **Procedimientos clínicos y asistenciales para la recuperación.** Reprogramación de cirugías y consultas diferidas, manejo de listas de espera generadas por la interrupción, estrategias para el cierre de casos clínicos complejos derivados del evento.
- **Procedimientos administrativos y logísticos.** Evaluación de daños a la infraestructura y equipos, reposición de insumos, medicamentos y materiales, regularización de la documentación (registros clínicos, administrativos, elaboración de informes).

3.3 Fase 2. Puesta prueba del plan

El objetivo es verificar si el PH-RED funciona en la práctica, identificar brechas y generar acciones de mejora, utilizando ejercicios de escritorio (simulaciones teóricas) y simulacros (ejercicios funcionales o de despliegue) idealmente con un enfoque multiamenaza.

3.3.1. Paso 1. Definir qué se quiere probar

i. Determinar el escenario, si es multiamenaza o específico para una amenaza (sismo, SMV, incendio, falla de energía, inundación, brote epidémico, QBRNE, violencia armada, cibernéticos, o varios de ellos de forma simultánea, en cascada o secuencial, etc.).

ii. Identificar y prepara los componentes del plan que se pondrán a prueba (activación de alertas, SCI-H/Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres, triage, evacuación, áreas de expansión, comunicación con RISS, continuidad de servicios críticos, etc.).

iii. Decidir el tipo de ejercicio:

- Ejercicio de escritorio (simulación teórica).
- Simulacro funcional (con movilización de recursos).

Paso 2. Planificar el ejercicio

iv. Nombrar un equipo de gestión del ejercicio (director, facilitadores, evaluadores, apoyo logístico).

v. Definir objetivo(s) del ejercicio, alcance (áreas y servicios participantes) y duración aproximada. incorporar métricas psicosociales

vi. Diseñar el escenario y la secuencia:

- Para ejercicios de escritorio: guion con línea de tiempo y mensajes (“inyectores”).
- Para simulacros: cronograma (minuto a minuto), momentos clave y acciones a ejecutar.

vii. Identificar y asegurar los recursos necesarios: salas, equipo audiovisual, figurantes, tarjetas de víctimas, radios, papelería, etc.

viii. Establecer medidas de seguridad (particularmente en simulacros) y mecanismo para suspender el ejercicio si ocurre una emergencia real.

Paso 3. Comunicar y preparar

ix. Informar al personal involucrado: fecha, hora, tipo de ejercicio, objetivos y reglas básicas.

x. Notificar, cuando aplique, a autoridades externas (Protección Civil, CRUM, CVOED, otros hospitales).

xi. Revisar brevemente con el personal los roles y responsabilidades tal como están definidos en el PH-RED (SCI-H, brigadas, tarjetas de acción).

Paso 4. Ejecutar el ejercicio

xii. Realizar una reunión de apertura breve (5–10 minutos) para recordar objetivos, escenario y tiempos.

xiii. Desarrollar el ejercicio según lo planificado:
- En escritorio: el facilitador presenta el escenario inicial y los mensajes; los participantes discuten y deciden cómo aplicar el PH-RED.
- En simulacro: se activa el código correspondiente, se despliega el SCI-H y se ejecutan las acciones (triage, evacuación, expansión, referencia, etc.).

xiv. Los evaluadores observan y registran decisiones, tiempos, flujos y dificultades, sin intervenir en las decisiones operativas.

xv. Cerrar el ejercicio con un mensaje claro de finalización y retorno a la operación normal (en simulacros).

xvi. Monitorear impactos psicosociales.

Paso 5. Evaluar resultados

xvii. Realizar una sesión de recapitulación “debriefing” inmediatamente después del ejercicio (idealmente ≤ 1 hora): ¿Qué funcionó bien?, ¿Qué no funcionó o generó confusión?, ¿Qué partes del PH-RED fueron útiles y cuáles no se aplicaron?

xviii. Consolidar la información de listas de verificación, notas de evaluadores y comentarios de participantes.

xix. Valorar el desempeño por capacidades clave (comando, comunicación, triage, logística, continuidad de servicios críticos, coordinación con la red integrada de servicios de salud, etc.).

xx. Evaluar el bienestar del personal.

Paso 6. Actualizar el PH-RED y la herramienta

xxi. Traducir los hallazgos en un plan de mejora con acciones concretas, responsables y plazos (por ejemplo: actualizar tarjetas de acción, ajustar áreas de expansión, reforzar cadena de llamadas, modificar procedimientos de triage).

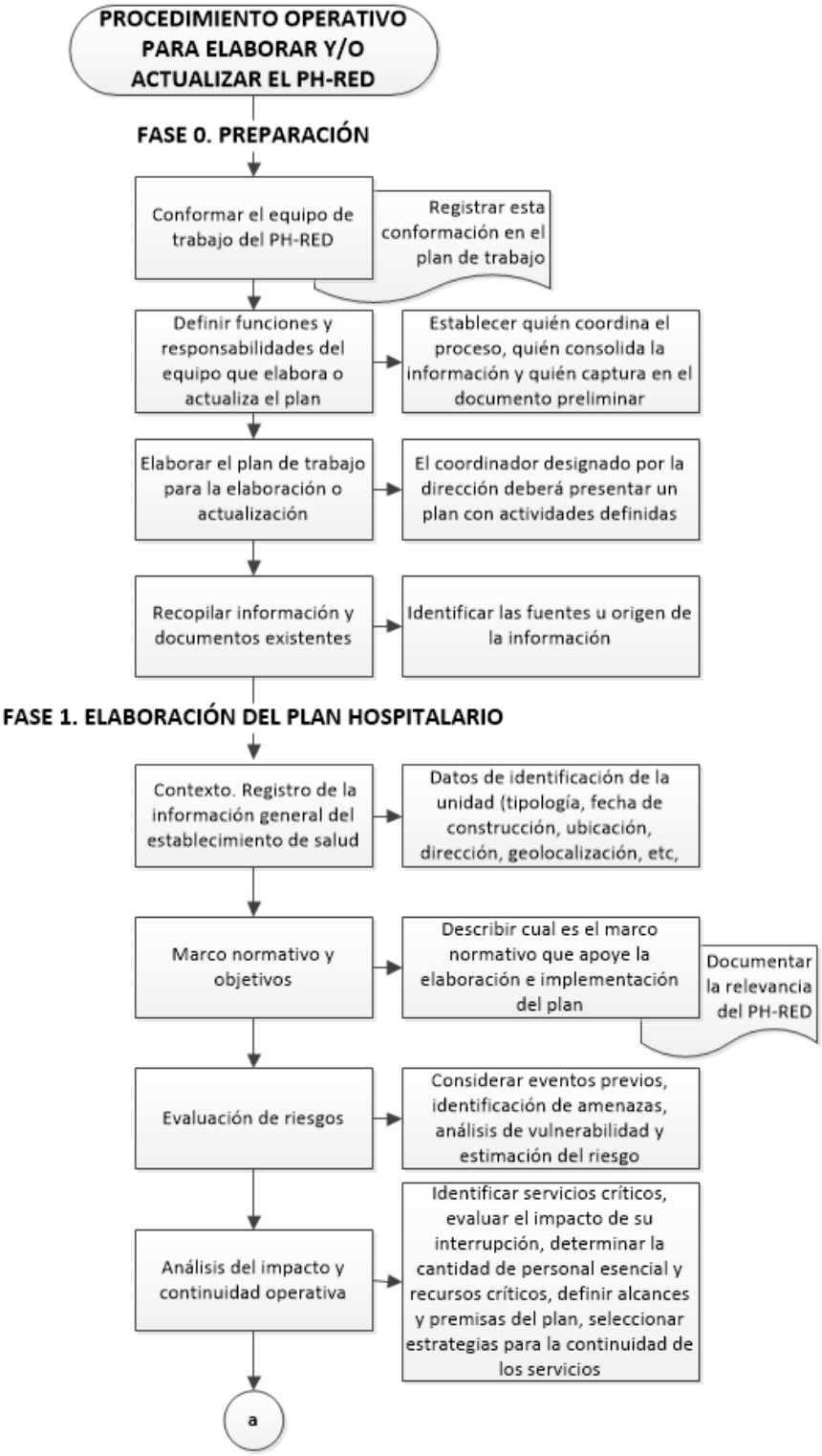
xxii. Incorporar los ajustes al documento del PH-RED (organización, planes de contingencia, áreas de expansión, etc.).

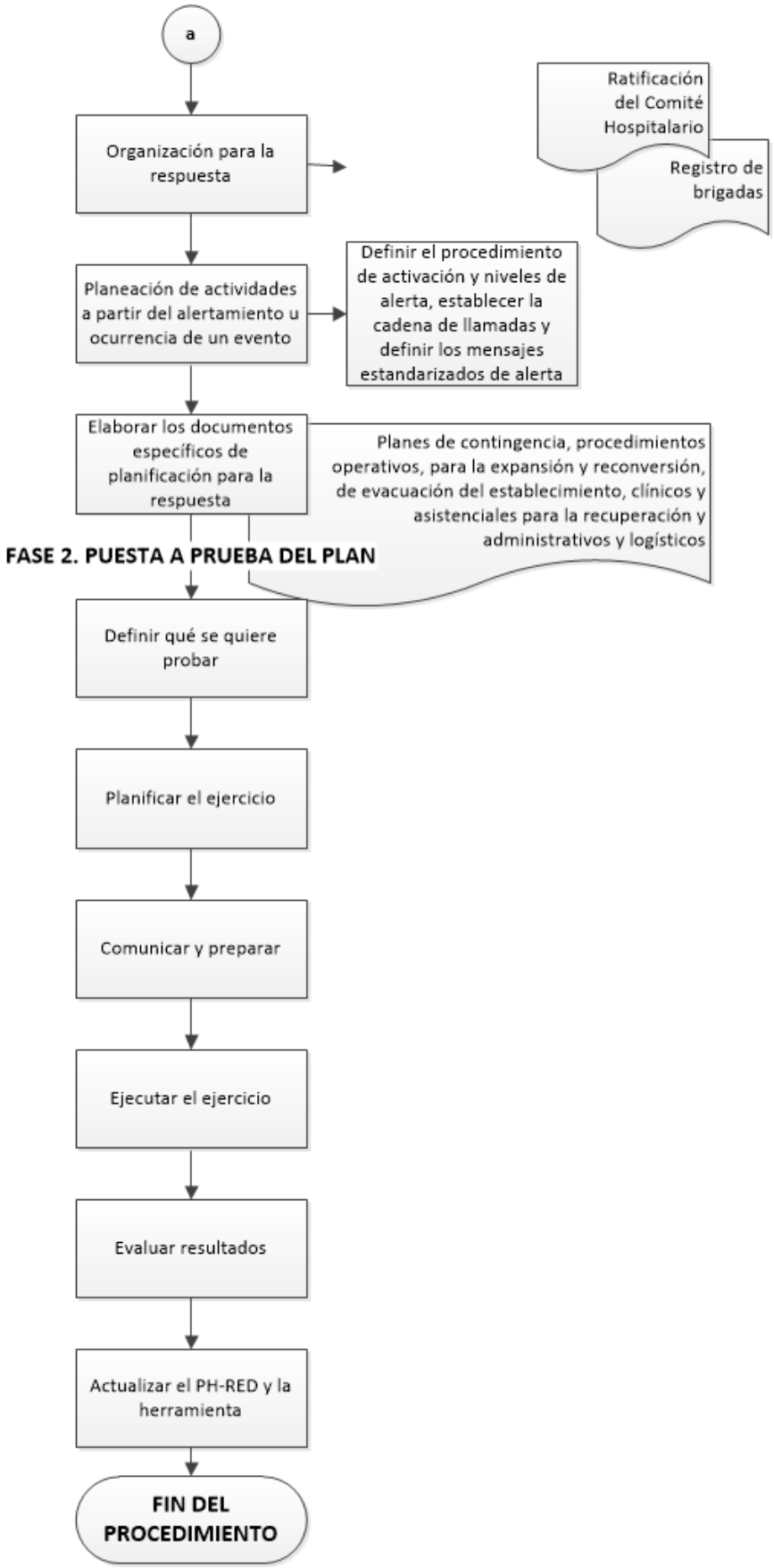
xxiii. Programar el siguiente ejercicio (de escritorio o simulacro) para verificar si las mejoras implementadas funcionan en la práctica.

xxiv. Incorporar lecciones de eventos cibernéticos recientes.

4. Anexos

Anexo 1. Diagrama de flujo para la elaboración del plan hospitalario de respuesta a emergencias y desastres (PH-RED)




a
Organización para la respuesta
Ratificación del Comité Hospitalario
Registro de brigadas
Planeación de actividades a partir del alertamiento u ocurrencia de un evento
Definir el procedimiento de activación y niveles de alerta, establecer la cadena de llamadas y definir los mensajes estandarizados de alerta
Elaborar los documentos específicos de planificación para la respuesta
Planes de contingencia, procedimientos operativos, para la expansión y reconversión, de evacuación del establecimiento, clínicos y asistenciales para la recuperación y administrativos y logísticos
FASE 2. PUESTA A PRUEBA DEL PLAN
Definir qué se quiere probar
Planificar el ejercicio
Comunicar y preparar
Ejecutar el ejercicio
Evaluar resultados
Actualizar el PH-RED y la herramienta
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Referencias

1. SALUD. Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/512104/NOM-016-SSA3-2012.pdf
2. Organización Panamericana de la Salud. Instructivo para elaborar un plan hospitalario de respuesta a emergencias de salud y desastres. 2023. OPS/PHE/CPI/23-0015. Disponible en: https://iris.paho.org/items/c2b62737-2fbe-471a-aa89-526b5962c6da
3. Organización Panamericana de la Salud. Plan de respuesta a emergencias de salud y desastres. Instrucciones para su elaboración y monitoreo. 2023. Disponible en : https://iris.paho.org/handle/10665.2/58046
4. Organización Panamericana de la Salud. STAR-H: Evaluación estratégica del riesgo de emergencias y desastres en establecimientos de salud. 2022. Disponible en: https://iris.paho.org/items/e55fb6a2-4b93-4a76-bc9e-05e2c428cc75
5. Organización Panamericana de la Salud. EVAC-H. Evacuación de hospitales y sus áreas críticas. 2024. Disponible en: https://iris.paho.org/items/a452ecd8-18fe-4b21-8c8c-2c529b793ece
6. Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones para fortalecer la seguridad no estructural de los establecimientos de salud ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos. 2024. Disponible en: https://iris.paho.org/items/0e8f1e53-fd0c-441c-adaf-dd5d249339cd
7. WHO. Hospital emergency response checklist. 2023. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/hospital-emergency-response-checklist

Recursos

Herramienta para la elaboración del plan hospitalario de respuesta a emergencias y desastres. IMSS. Disponible en: https://1drv.ms/f/c/3857830a47a17b3d/IgB2shwsc_cRS5BZVIjn7FStARVG0XqW1M10RCUPfdIXTzM?e=zWmZnc

Curso: Sistema de Comando de Incidentes para Hospitales (SCI-H). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/sistema-de-comando-de-incidentes-para-establecimientos de salud.

Curso: Marco de respuesta multiamenaza: Planeamiento hospitalario para la respuesta a emergencias en salud y desastres. Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/respuesta-multiamenaza-planeamiento-hospitalario-emergencias

Curso: Expansión de la oferta de servicios en emergencias de salud y desastres. Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/expansion-servicios-emergencias

Curso FEMA: Active Shooter Preparedness (IS-907). Disponible en: https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-907

Contacto

Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED)

(24/7 los 365 días del año)

Teléfonos:

55 52 62 53 68 (directo)

55 52 38 27 00 (conmutador), Extensiones: 19081, 19083, 10315, 19832 y 19831

55 80 03 58 24 (WhatsApp)

Sitio web: https://cvoed.imss.gob.mx

Correo electrónico: cvoed.coord@imss.gob.mx